第五章 全科医学中的医患沟通与法律问题

本章数字资源

学习提要

- 医患关系是在医学实践中产生的人际关系，具有人际关系的通用属性，又有其特殊之处。对医患关系概念、内容、特征及不同类型医患关系特点的学习，能使医学生深入了解医患关系的深层次内涵，为其将来从事医务工作提供帮助和指导。
- 建立并维系良好的医患关系对全科医学服务至关重要，掌握其方法和策略能够帮助医学生更好、更快地适应未来工作环境。
- 通过对沟通的概念、要素、原则、影响因素的学习，医学生能更加深刻地理解医患沟通的意义；熟练掌握并运用语言性沟通和非语言性沟通技巧是全科医生应当具备的素质。
- 医患双方的权利与义务是从法律层面对医患“为”或“不为”的具体规定，熟练掌握该内容是医学生学法、知法、用法的体现，是维护医患双方合法权益的基础。作为一名合格的全科医生，要懂得依法执业，规范自己的诊疗行为，有效应对常见的法律问题。

第一节 | 全科医学中的医患关系

一、医患关系概述

（一）医患关系的概念

医患关系（doctor-patient relationship）是指在医学实践活动中所产生的人际关系。医患关系的概念有广义和狭义之分。广义的医患关系是指以医生为主体的与从事医学活动有关的“医方”群体，同以患者为主体的与就医行为有关的“患方”群体之间的人际关系。“医方”既包括医生、护士、药师、技师等医务人员，又包括医疗机构及其行政、后勤等管理工作人员；“患方”不仅包括患者本人，还包括患者的亲属、监护人等关系人。狭义的医患关系是指医生与患者及其关系人之间形成的人际关系。本章中的医患关系是指狭义的医患关系。

（二）医患关系的内容

根据是否与医学技术实施有关，医患关系可分为技术关系和非技术关系。

1. 技术关系 指医生运用医学技术向患者提供诊断、治疗、预防、保健、康复等具体医疗服务过程中形成的互动关系。技术关系是医患关系最基本和最主要的表现形式，是非技术关系产生和形成的基础。

2. 非技术关系 指医生与患者及其关系人在诊疗过程中因情感、思想、心理、社会、伦理、法律等诸多非技术因素而构成的互动关系。非技术关系主要包括以下几个方面。

（1）道德关系：人际关系需要用一定的道德原则和规范来约束。医患关系属于一种特殊的人际关系，更需要医患双方遵循一定的道德规范。作为医生，应具有高尚的道德修养和崇高的敬业精神，关心、爱护和尊重患者；作为患方，应如实向医生提供病情，配合医生的诊疗工作，遵守医院规章制度，尊重医务人员及其劳动，自觉维护医疗机构的正常工作秩序。

（2）价值关系：医患双方通过诊疗活动体现或实现各自的价值诉求，从而形成一定的价值关系。

医生通过医学知识和技术为患者提供医疗服务，得到患方和社会的认可与尊重，实现自身价值；患者通过接受诊疗而减轻痛苦、恢复健康、延长生命，从而更好地承担社会角色。

（3）情感关系：医患双方围绕诊疗活动实现各自价值的过程中，也会形成一定的情感关系。患者因疾病带来的不适导致情绪低落，甚至产生心理负担，在情感上希望得到医生的关心和帮助，以增强战胜疾病的信心。医生希望在情感上得到患方的理解与支持，从而为更好地服务患者提供精神动力。

（4）经济关系：医疗活动是一种特殊的经济活动。医患关系是在医疗活动中产生的，为满足医患双方各自需求而形成的一种利益关系。在这种关系中，医生通过诊疗活动付出一定的体力和脑力劳动，从而获得劳动报酬；患者通过接受诊疗服务而恢复健康，或延长生命、减轻痛苦、提高生存质量，并为此支付诊疗费用。

（5）法律关系：随着社会发展和医学进步，医患关系不仅需要道德的约束和规范，更需要法律的调解。医患双方必须在法律法规和制度约束的范围内行使自身的权利，并履行相应的义务。就患者而言，从挂号开始，便与医方建立起了契约关系，受相应的法律法规和制度的保护与监督，如果患者权益受到损害，可依法追究医疗机构及医务人员的责任；就医生而言，其权利和义务同样受法律法规和制度的保护与制约，如果其权益受到损害，也同样可以通过法律途径解决。

（三）医患关系的特征

1. 双方目的的同一性 医患关系是围绕患者健康和诊疗活动建立起来的人际关系，因此，医患双方的目的是一致的，即最大限度地解除或减轻患者痛苦、恢复健康、延长生命。

2. 双方利益的一致性 在诊疗过程中，医生通过提供良好的诊疗服务而获得合理经济收入，并满足心理和精神需求，实现人生价值；患者通过接受医生的服务而减轻痛苦、重获健康，进而恢复其一定的家庭和社会角色。

3. 双方信息的不对称性 医学是一门专业性强、技术含量高、知识更新快、风险程度高，且广泛涉及社会人文的学科。医生需要经过长期不断的专业学习和临床实践，并通过国家统一组织的医师资格考试，进行执业医师注册，这一过程客观上使医生掌握了大量的、专业的医学知识。而对于寻求医疗服务的患者而言，即使通过读书、网络或专家咨询获得相关医学信息，仍与医生掌握的相关科学技术和实践经验不相匹配，是信息劣势方，一般只能被动地接受信息。

4. 医疗过程的互动性 要达到良好的疾病诊疗效果或健康恢复效果，需要医患双方共同努力，仅依靠一方难以实现这一目标。医生开具的物理检查、实验室检验或实施的相关技术操作，需要得到患方的认同与配合，以确保患者健康利益的最大化。反之，如医生不积极对患者疾病进行全面系统诊疗，或患者拒绝执行医生的合理诊疗方案，就难以实现良好的诊疗效果。

（四）医患关系模式类型

医患关系模式（doctor-patient relationship model）是指在历史和现实中存在的具有一定普遍性和代表性的医患关系样式。目前，国内外学者广泛认可的是1956年美国学者萨斯（Szasz）和荷伦德（Hollender）在《内科学成就》中发表的《医患关系的基本模式》中提出的医患关系模式，即主动-被动型、指导-合作型和共同参与型（表5-1）。

表5-1 萨斯-荷伦德医患关系模式表

模式	医生地位	患者地位	适用对象	类似关系
主动-被动型	绝对权威	被动接受诊疗	休克昏迷、急诊重度外伤及意识丧失患者	父母与婴儿
指导-合作型	指导作用	积极配合诊疗	意识清醒的急性期、感染期患者	父母与青少年子女
共同参与型	帮助作用	积极协助诊疗	慢性病、心理疾病及有一定医学知识的患者	成人与成人

1. 主动-被动型 是一种传统的医患关系模式。其特征是医生在诊疗过程中起主导作用，患者被动接受医生的诊疗行为和方式。这种模式适用于无关系人照护的休克昏迷、急诊重度外伤及意识

丧失患者。

2. 指导-合作型　是现代医患关系的一种基本模式。医生起指导作用，患者在接受医生诊疗方案和意见的情况下发挥自身的积极性，从而提高疗效、恢复健康。此种模式的应用对象主要是意识清醒的急性期或感染期患者。

3. 共同参与型　是现代医患关系模式的一种发展趋势。其特点为患者不是被动接受诊疗，而是主动的参与者，包括积极协助医生作出正确诊断、制订和实施诊疗方案、密切跟踪反馈治疗效果等。慢性病、心理疾病以及具有一定医学知识的患者一般适用这种模式。

（五）全科医学中的医患关系特点

全科医学中的医患关系不仅具备其他专科医患关系的基本属性，还具有其自身的特点和优势。

1. 共同参与的互动关系　全科医学强调以人为本、以健康为中心，将患者置于其家庭背景和社区环境中，运用家庭力量、社会人际关系等协同解决其健康问题。全科医生与服务对象进行沟通时，要鼓励其积极主动参与交流，通过开放式提问等沟通技巧尽可能多地了解其性格特点、生活习惯、家庭结构、人际关系、经济状况、工作性质等情况，与其共同分析存在的健康危险因素，并提供个体化建议。此外，寻求全科医学服务的多数就诊者为慢性病患者，他们在长期的诊疗过程中积累了很多经验，对疾病形成了一定的认识和理解，能够更好地与全科医生进行互动。

2. 全面照护的协同关系　全科医生提供的是基本医疗服务，面对的患者很多处于疾病未能明确诊断的早期，或共病患者，因此全科医生提供的医疗服务应主要定位在照护上，并且是全生命周期的照护。全科医生应努力调动各种积极因素，帮助他们制订诊疗方案、预防并发症、疏解负向情绪、指导合理饮食和养成良好生活习惯。全科医生要让服务对象客观地认识自身的健康危险因素及所患疾病的特点，使其善于与自己的疾病“相处”，并能调动一切积极因素促进健康。

二、全科医学中良好医患关系的建立与维护

（一）建立与维护良好的医患关系的重要意义

全科医疗的医患关系有别于其他专科医疗的医患关系。从形成动机的角度看，其他专科医疗的医患关系是随着患者就诊而形成的，对医生而言，医患关系的形成是被动的；而对于全科医生，只要居民在全科医疗服务的签约范围内，就有义务积极了解居民健康状况，建立居民健康档案，因此医患关系的形成是主动的。从患者管理周期的角度看，专科医疗的医患关系一般是一过性的人际关系，在门诊及住院诊疗接触过程中形成和建立，随着患者健康问题的解决或疾病的恢复而结束；全科医疗是面对社区居民全生命周期的健康管理和照护，其医患关系长期且持久。从病种管理的角度看，其他专科医疗医患关系往往建立在针对某一种或几种疾病的诊疗基础上；而全科医生要以居民个体为对象，负责居民的疾病预防、诊断、治疗、控制，健康教育，生活指导乃至临终关怀等全方位的全生命周期服务。

因此，对于全科医生而言，良好医患关系的建立与维护至关重要，体现在以下几方面。

1. 是做好全科医疗工作的基础　全科医疗服务具有基础性、持续性、个体化、综合性和协调性的特点，其服务内容贯穿于全生命周期，并着重关注特定阶段的特殊生理、心理、家庭和社会方面的健康问题。这一特点决定了全科医疗服务不同于其他专科医疗服务，全科医生不仅要解决患者当前的健康问题，还要注重探寻当前健康问题与既往疾病和生活习惯的联系，调动患者和其家庭成员的主观能动性，主动参与到疾病的预防和诊疗过程中，从而找到更为恰当的干预措施。因此，全科医疗服务目标的实现，必须建立在长久的良好医患关系的基础上。

2. 是提高医疗工作质量的前提　良好医患关系是全科医生与患者形成积极互动的催化剂。全科医生对患者的关心、对病情的重视、对注意事项的详细告知、对患方疑虑的耐心解答等本身就是一种治疗方式，能够缓解患者的焦虑情绪，减轻患者的身心痛苦，增强患者战胜疾病的信心，提高患者的依从性，使医患双方能够更好地配合，从而产生更强的“治疗合力”，不断提高全科医疗服务质量。

3. 是全科医生可以调动的资源　全科医生在社区医疗工作中往往扮演着一个“多面手”的角

色，既是负责疾病诊疗、健康维护、病患照护和全方位健康管理的医生，又是进行疾病危险因素早期筛查、促进健康生活方式形成的教育者；既是社区医疗卫生资源的“守门人”，又是社区医疗卫生保健工作的管理者；既是实现社区与各级各类医疗卫生机构双向转诊的沟通者，又是建立社区健康档案与社区健康网络的组织协调者。这些角色的实现，都需要全科医生调动其良好的医患关系资源，带动大家参与到健康维护与健康促进的工作中，从而提高人群整体健康水平。

4. 是促进全科医学发展的催化剂 良好的医患关系能够促使全科医生关心患者，热爱本职工作，给自己带来积极的成就感和满足感，有效激发全科医生的内在动力，不断提高全科医疗的服务水平和能力，进而促进全科医学事业的健康发展。同时，良好医患关系也能促使广大服务对象关注全科医生的学习、生活和工作，关心全科医生的职业发展，为全科医学工作的不断改进和完善建立坚实的群众基础。

（二）建立与维护良好医患关系的有效策略

全科医学中良好医患关系的建立与维护要以人际信任为基础。人际信任在人类交往和社会生活中至关重要，是人与人之间建立稳定和持久关系的基石，也是社会运行的润滑剂。在推进分级诊疗制度落实过程中，患者对基层医疗卫生服务缺乏信任是制度落实的瓶颈之一。全科医生良好的职业素养、优质高效的医疗服务、以患者为本的理念、充分有效的沟通，以及自身的良好形象都是人际信任构成的必要因素，也是打破这一瓶颈、建立和维护良好医患关系的有效策略。

1. 培养良好的职业素养 全科医生的职业素养与其世界观、人生观、价值观、道德修养、医疗能力以及对职业和生活的态度等因素密切相关。全科医生应重视生命，尊重生命，并富有同情心和爱心，对待患者存在的健康问题持亲切、关怀、真诚与负责的态度，善于理解患者的愿望并尽可能地给予帮助，在工作、学习、生活中培养良好的职业素养和道德情操，从而建立良好的医患关系。相反，全科医生如果对患者的健康问题漠不关心、得过且过，则会降低患者的信任度，甚至引发医患矛盾。

2. 提供优质高效的服务 全科医生工作的“产出”是通过服务对象的满意度来体现的，而其满意度是通过全科医疗工作过程实现的。全科医生要以不断满足患者日益增长的健康需求为导向，在学校教育的基础上尽可能多地参加继续教育、专业培训和学术研讨等活动，加强与国内外同行的交流学习，不断提升自身的医德修养、业务知识、技术水平和工作能力，同时要做好社区居民健康需求调研。只有这样，全科医生才能为服务对象提供更为优质高效的诊疗服务，通过满足诊疗需求而获得患者的信任，使其乐于得到全科医生的帮助与指导，从而有效促进和谐医患关系的维护。

3. 坚持以患者为本的理念 时刻把患者利益放在首位是全科医学“以患者为本”这一理念的最佳体现。全科医生通过提供与健康相关的医疗服务来获得报酬，但不能为了获得更高的经济利益而损害患者的利益。此外，除健康服务，在进行需要患者或居民配合的社区工作时，也要尊重对方的意愿，并在其知情同意的基础上开展。只有树立以患者为本的服务理念，才能使全科医疗中的医患关系更加良好而长久。

4. 建立充分有效的沟通 良好医患关系的建立与全科医生的沟通能力和沟通技巧密切相关。全科医生要注重沟通能力的培养，平等对待患者，尊重患者的人格，更多地站在患者角度理解其痛苦和不适，真诚帮助患者解决问题。在沟通的过程中，全科医生应尽可能地听取患者对健康问题的叙述，并尽量使用关心、支持、安慰、鼓励和劝导性语言，增强患者战胜疾病的勇气和信心。同时，全科医生也要注意沟通技巧的学习和使用，针对不同的对象、不同的健康问题采用不同的语言性和非语言性沟通技巧，以达到事半功倍的效果。

5. 身体力行树立良好形象 全科医生自身的良好形象能起到榜样的作用，运用自身生动事例来教育人、影响人，能够弘扬正确价值取向，增强教育的感染力和实效性。全科医生要身体力行，养成良好的生活方式和习惯，为患者起到榜样的作用，增强患者对全科医生的信任与尊重，从而有利于良好医患关系的建立和维护。

除此之外，在互联网时代，社交媒体因具有连接关系网络的属性和即时通信的功能，已成为人际

关系维护与拓展的重要媒介，全科医生可以通过科学合理地应用新媒体手段，加强与维护良好的医患关系。如利用社交软件群、社区就诊 APP 等推送健康指导、疾病预防、康复常识、急诊急救等相关信息，不受时间、地域的限制，并将其作为医患及时、有效、持久交流健康信息的必要补充形式。

第二节 | 全科医学中的医患沟通

一、沟通概述

（一）相关概念

沟通（communication）一词，在西方是由拉丁文 communis 演变而来，原意是“分享和建立共同的看法”；在我国，沟通原指开沟以使两水相通，后泛指使两方相通连，也指交流彼此的意见。虽然东西方对沟通的释义不尽相同，但其核心都是指双方之间信息传递和理解互动的过程。

人际沟通（interpersonal communication）是指人们为达到一定的目的，通过一定渠道，交流思想、感情和知识等信息的过程。简单地说，人际沟通就是交流信息的过程，就是人与人之间信息的传递与互动。

（二）沟通的要素

根据 Hein 于 1973 年提出的理论，沟通的基本要素包括信息背景、信息发出者、信息、信息传递渠道、信息接收者、反馈六个要素。

1. **信息背景**（information background） 是指沟通过程所在的环境，包括地点、周围条件、沟通的时间，以及沟通参与者的个人特征（包括知识水平、经历、文化背景及心理特征等）。

2. **信息发出者**（message sender） 是把自己的思想、情感、知识等信息传递出去的一方。

3. **信息**（message） 是沟通的具体内容，是个体思想、背景、态度、个性、知识、行为模式、价值观等的表现形式，包括语言性信息和非语言性信息。

4. **信息传递渠道**（route of message transmission） 是指信息传递的手段、方式、途径、通道，是信息由一方传递给另一方所经过的路径。

5. **信息接收者**（message receiver） 是指接收信息的一方。只有当信息接收者接收到信息发出者发出的信息，才能形成有效沟通。信息接受过程包括接收、解码和理解三个步骤。在一定的条件下，信息接收者和发出者常常互换角色。

6. **反馈**（feed back） 是指信息接收者接到信息后的反应和回馈，是信息发出者和信息接收者之间相互反应的过程。反馈是沟通的重要组成部分，通过反馈可以评价沟通的有效性。

在全科医学的医患沟通中，无论是医生作为信息发出者，患者作为信息接收者（如健康指导、健康讲座等）；还是患者作为信息发出者，医生作为信息接收者（如患者主诉病史等），医患双方都需要在发出信息后注意接收对方的反馈，不断实现沟通角色的互换，最终达到解决健康问题的目的。以社区健康咨询过程为例，图 5-1 展现了沟通构成的要素。

（三）沟通的基本原则

1. **诚信**（sincerity） 是建立良好人际沟通的前提和基础。全科医生在工作中一定要抱着真诚的态度与对方沟通，对自己许诺或已与对方达成共识的事情，做到言必信、行必果，为良好有效的沟通奠定基础。

2. **平等**（equality） 在全科医疗中，平等包含两方面含义，一方面是全科医生与社区居民地位和关系上的平等；另一方面是全科医生对待不同的服务对象时要一视同仁、平等相待。

3. **尊重**（respect） 尊重分为自尊和他尊，在尊重自己的同时，也要尊重他人。沟通过程中充分尊重对方，自然会得到对方的尊重，使双方产生共鸣，建立融洽的关系。

4. **移情**（empathy） 即沟通双方设身处地站在对方的角度，通过认真地倾听和提问，理解对方的

NOTES

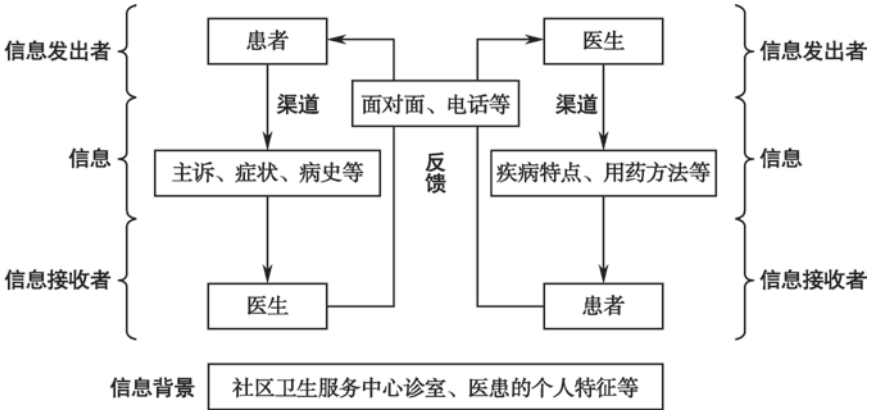


图 5-1 社区健康咨询过程中的沟通要素示意图

感受，并以正确的方式把这种感受传递给对方。

5. **理性**（reason） 是指沟通双方能够客观、理智地了解、认识和分析沟通的内容，避免情绪化和非正常思维带来的干扰。全科医生要学会调整自己的情绪，清醒地思考问题，以便达到充分有效的沟通效果。

6. **慎言**（cautious） 沟通的语言既可“治病”，也可“致病”。沟通过程中，要出言谨慎，避免使用自大、夸张、批评、责备、抱怨、攻击性的语言，避免触及对方隐私，避免口无遮拦、喋喋不休。

（四）影响沟通的因素

影响沟通的因素既包括沟通方式、沟通地点、沟通环境等外在因素，又包括沟通者表达能力、理解能力、身体状况、心理特征、情绪状态、个人修养等内在因素，这些因素的条件、状况往往决定沟通的成败。

1. **沟通方式** 也就是前面所叙述的信息传递渠道，其形式多样，而且不同的沟通方式往往解决不同的问题。以全科医疗中医患沟通方式为例，其优缺点和适用范围见表 5-2。

表 5-2 全科医疗中常见的沟通方式、优缺点及适用范围

沟通方式	优点	缺点	适用范围
大众传媒（如电视、广播、报纸等）	覆盖面广，易解决居民“知”的问题	缺少居民“信”和“行”的反馈	指导或解决人群间共性健康问题
面对面交谈	可实现一对一交流，利于信息的传递，易达到完全互动	对沟通双方时间要求严格，效率低	解决所有全科医疗对象的个性化健康问题
电话沟通	可实现一对一交流，实现互动，方便快捷	不能传递眼神、表情等非语言信息	无听力障碍人群的个性化健康指导
健康讲座	易实现居民健康知识的宣教和普及	居民反馈少，难以解决个性化的健康问题	某特定区域有共同健康需求的人群
社交媒体	兼具大众传媒和个体沟通两种功能	在对网络、智能手机等不熟悉的人群中难以实行	指导或解决人群间共性及个性健康问题

2. **沟通地点与环境** 在进行人际沟通时，不同的沟通地点往往会产生不同的沟通效果。沟通环境指沟通双方所处地点周围状况和情境，往往与沟通地点密切相关。如全科医生在诊室对居民进行问诊时，场合比较正式，空间相对封闭，有利于患者表述自己的真实感受、个体隐私；在社区街道，流动人群较多，不宜谈及过多私密话题；在对社区居民进行家庭访视时，环境相对安静，氛围融洽，容易与受访者拉近心理距离，可就居民存在的健康问题进行较为细致的沟通和探讨，有利于唤起其他家庭成员对其健康状况的关注；在社区举办健康讲座时，能够促使社区居民对普遍和共性的健康问题产生共鸣。

3. 沟通双方的表达和理解能力　与沟通者的家庭环境、成长环境、受教育程度、社会接触情况、个人努力程度等密切相关。一般来说，家庭氛围融洽、成长环境和谐、受教育程度高、社会接触面广，并有意识不断完善自我的沟通者，具有较强的表达能力和理解能力，更容易获得良好的沟通效果；反之，对于单亲或家庭氛围长期紧张、成长环境封闭、接受教育贫乏、社会接触面窄且对自我要求低的沟通者，表达能力和理解能力相对欠缺。

4. 沟通双方的身心及情绪状态　双方身心放松、情绪稳定，使表达内容更加系统、清晰和明确，有利于信息的有效交流；如果沟通的一方或双方身体不适或存在焦躁、不安、愤怒等负面情绪时，沟通效果会大打折扣。

5. 沟通者的修养　是基于个体心理特征的人的综合素质的体现。一个人的能力、气质、性格、品德修养等对沟通效果起着举足轻重的作用。性格乐观、态度积极、心胸豁达的人往往能够结交更多的朋友，赢得更多的信任，也更容易与他人进行充分有效的沟通。而品质恶劣、性格孤僻、多疑、自卑、嫉妒等都会阻碍人际沟通的有效进行。

二、全科医学中医患沟通的技巧

医患沟通（doctor-patient communication）是指在医疗卫生保健工作中，医患双方围绕疾病预防、诊疗、保健、康复等主题，以患者为本，以医生为主导，对各种信息进行全方位分析和多途径交流的过程。全科医疗服务中，良好有效的医患沟通有利于为患者提供优质的医疗卫生和保健服务。

全科医学中的医患沟通技巧可分为语言沟通技巧和非语言沟通技巧。

（一）全科医学中的语言沟通技巧

1. 运用得体的称呼语　称呼语是语言沟通的开始，全科医生恰当地使用称呼语会给患者留下良好的第一印象，为后续的沟通奠定相互尊重和信任的基础。医生要根据患者性别、年龄、身份、职业等特征的不同而使用不同的称谓，力求尊重为先、恰当自然。可使用叔叔、阿姨、先生、女士、小朋友等，避免使用诊号、床号取代称谓。对经常接触或长期接受全科医生健康照护的患者，可以直接称呼为老李、小王等，以拉近双方之间的距离。

2. 营造和谐的沟通氛围　全科医生接待患者应面带微笑，温和招呼，请其落座，以示尊重，使患者处于放松状态，融洽就医氛围。可以“言他式”开场，避免直入主题。如以小区最近关注的话题入手，过渡到对患者病情的询问。此外，全科医生应尽量保持诊室环境的整洁、安静，避免接打电话、随意走动及闲杂人员出入，干扰沟通过程。

3. 主动倾听积极反馈　倾听是实现良好有效医患沟通的重要手段，可以使患者感受到医生的尊重和理解，便于患者向医生传递自身的健康信息和真实感受。全科医生与患者沟通时应与对方保持适当的目光接触，集中精力倾听其叙述，观察其面部表情和肢体语言，正确“阅读”所传递的信息，并给予适时反馈。在倾听的过程中，医生一方面要善于采用认同的语言鼓励对方叙述；另一方面也要以“是这样啊”“接下来呢”等话语积极回应对方，并根据需要重复对方所叙述的重要信息，避免信息的缺失。

4. 形象化表达医学术语　全科医生的语言既要准确、简练、条理分明，又要使患者容易理解和接受。因为医患双方存在着掌握医学信息的程度、理解能力、受教育程度等因素的差异，所以在双方沟通过程中，应该尽量使用通俗易懂的语言，避免产生误解，影响沟通效果。在不得不使用深奥难懂的医学术语时，医生可以借助图片、模型、影像等资料加以释疑，必要时可以采用比喻、类比等修辞手法进行形象化说明，使对方充分理解和接受所要表达的内容。

5. 从患者角度看待问题　根据不同患者的特点，采用不同的沟通方式，其核心就是换位思考。全科医生面对的患者各异，每个患者的健康问题千差万别，即使是同一患者、同样的健康问题，也会因时间的不同而需要采取不同的方式、方法。这就要求全科医生须站在患者的立场来看待其陈述的健康问题，从根本上采取有效的针对性措施加以解决。

NOTES

6. 开放式与封闭式提问相结合 开放式提问的回答范围没有限制，有利于患者开拓思路，充分、主动、自由地表达自己的观点和真实想法，如，您最近身体有什么不舒服吗？封闭式提问将应答限制在特定范围内，患者回答的选择性小，甚至只能用简单的“是”“不是”“有”“没有”来回答。此外，全科医生是交谈的主导者，在让患者充分表达自己的想法和要求的同时，也要注意引导交谈的方向，使交谈流畅有效。

7. 适宜的语气、语调和语速 ①语气有肯定、陈述、疑问、感叹等，能够体现交谈者的情感和态度，全科医生的语气应该亲切自然，充满关爱；②语调即说话的腔调，就是声调高低、抑扬轻重的配合和变化，对同一事情的阐述，语调不同，往往传递的情感也不同，全科医生应该善于使用、控制和转换不同的语调；③语速是指说话的速度，沟通时语速应该急缓适宜、停顿适当，以更好地吸引患者的注意力，使其更易接受和吸收全科医生所表达的信息。

（二）全科医学中的非语言沟通技巧

1. 衣着得体 衣着是指人的穿衣打扮，可以展现一个人的整体精神面貌。全科医生的穿衣原则是干净、整洁、得体。当与患者初次接触时，如果医生的衣着符合患者的心理预期，会降低患者的焦虑情绪，给患者留下良好的印象。反之，则会降低患者对全科医生的信任和期待，影响沟通质量。

2. 正确理解和表达面部表情 面部表情是人类情绪、情感的外在表现。全科医生一方面要善于“读懂”患者面部表情所传递出的信息；另一方面也要以合适的面部表情反馈给患者。

3. 善于运用眼神传递信息 眼神是非语言沟通的重要组成部分，正确理解患者眼神传递的信息并以恰当眼神及时反馈，对医患沟通尤为重要。全科医生与患者保持适当的目光接触，有利于鼓励患者继续讲述病情。目光坦诚，充满仁爱，能够增强患者对医生的信任，拉近医患心理距离。应该注意，不宜一直盯着患者的眼睛，也不要目光游离或斜视患者，而应注视患者面颊下部，以示尊重和重视。

4. 运用恰当的身体姿势 身体姿势能够反映双方的心理及情绪状态，可以体现双方的态度和意愿。在患者叙述时，全科医生可以适当与对方缩小距离，上身微微前倾，以表示愿意倾听；在患者讲话迟疑有顾虑时，可以和其握手或拍肩以表示关怀，并愿意为其保密。

5. 保持合适的交谈距离 全科医疗服务中，医患双方的交谈距离因医患关系及场合的不同而不同。一般来说，全科医生与患者应该呈一定角度而坐，间隔 0.5~1.0m，并避免面对面直视，从而便于双方目光自由接触和分离，而不致尴尬和有压迫感。此外，全科医生也要根据文化、地区、民族和风俗习惯的不同，而采取不同的交谈距离，使对方易于接受。

6. 营造和谐的沟通环境 沟通环境会影响全科医疗服务中双方的心理及情绪状态，甚至决定沟通的成败。沟通环境要通风良好、光线柔和、整洁安静，并做到一医一患，以更好地保护患者隐私，达到良好的沟通效果。

第三节 | 全科医学中的法律问题

一、全科医学中的医患权利与义务

医患关系是一种合同或契约关系，属于民事法律关系范畴。医疗合同关系是医患关系的基本形态。

医疗合同（medical service contract）是指医方为患者提供医疗服务，患方为此支付费用的合同。医疗合同为诺成合同，双务有偿合同，其主要内容由医患双方彼此的权利和义务构成。

需要指出的是由于医生职业的特殊性，其权利义务不仅是针对患者的权利义务，也可能是针对医疗机构、卫生行政部门或国家和社会的权利义务。本节将根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗纠纷预防和处理条例》《医疗机构管理条例》等主要法律法规的相关规定，对医患双方的权利和义

务进行梳理，以更好地指导全科医学的实践活动。

（一）法律权利与法律义务

法律权利（legal right）是指国家通过法律规定，对法律关系主体可以自主决定为或不为某种行为的许可和保障手段。

法律义务（legal obligation）是指法律关系主体依法承担的某种必须履行的责任。

法律权利和法律义务具有如下关系。

1. 法律关系中的对应关系　指法律权利对应着相应的法律义务而存在，二者相互关联、对立统一。主要体现在：①在任何法律关系中，一方主体有法律权利，对方主体就必然承担相应的法律义务，反之亦然；②在特定的法律关系中，每一主体在享有权利之时都对应承担一定义务。

2. 社会生活中的对等关系　权利总量和义务总量是对等的。主要表现在：①如社会生活中权利总量大于义务总量，有些权利就形同虚设，反之，社会将产生特权；②在某种具体法律关系中，权利总量与义务总量也是对等的。

3. 功能发挥中的互动关系　法律功能常常通过其设定的权利与义务表现出来。主要体现在：①法律义务的履行促进法律权利的实现；②法律权利的享有也有助于法律义务的履行。

4. 价值选择中的主从关系　由于国家本质和社会制度的不同，决定了有些国家的法律体系以权利为本位，有些国家的法律体系以义务为本位。我国由于市场经济模式的建立以及对人权的普遍关注，现代立法总体上讲是以权利为本位的。

（二）医生的权利与义务

1. 医生的权利

（1）对患者进行诊疗：医生在注册的执业地点、执业范围内，具有进行疾病调查、医学诊查、医学处置以及选择合理医疗、预防和保健等方案的权利。

（2）出具相关医疗证明：在法律法规规定的范围内，医生具有开具与自己诊疗活动相关的各种业务证明的权利。

（3）获得基本工作条件：按照国务院卫生行政部门规定的标准，医生有获得与其执业活动相当的基本工作条件的权利。

（4）参加科研学术活动：医生有从事医学研究、学术交流和参加专业学术团体的权利。

（5）接受培训学习：医生有参加专业培训、接受继续医学教育的权利。

（6）人身权利：在执业活动中，医生享有人格尊严和人身安全不受侵犯的权利。

（7）获取合理报酬：医生有获取工资报酬和津贴以及享受国家规定的福利待遇的权利。

（8）参与权：医生有对所在机构的医疗、预防、保健等工作和卫生行政部门的工作提出意见和建议的权利，以及依法参与所在机构民主管理的权利。

（9）医疗费用支付请求：医生有为患者提供诊疗服务而获得报酬的权利，患者有为此支付医疗费用的义务。因此，医生有权要求患者缴纳费用。

（10）特殊干预：在特殊情况下，为保证患者自身、他人和社会的权益，医生可以采取限制患者自主权利的措施。但是，这种限制措施不是任意行使的，必须要满足一定条件，包括：①需要进行隔离的传染病患者或疑似传染病患者；②严重精神病患者和自杀未遂或有自杀倾向患者拒绝治疗时，可采取约束和控制措施；③当进行试验性治疗的患者出现危险情况时，医生必须及时终止治疗。

以上医生的权利受法律保护。干扰医疗秩序，妨碍医务人员工作、生活，侵害医务人员合法权益的，应当依法承担法律责任。

2. 医生的义务

（1）提高医德修养，关爱患者：医生应当具备良好的职业道德和医疗技术水平，发扬人道主义精神，履行防病治病、救死扶伤和保护人民健康的职责。

（2）规范执业行为，提高业务水平：医学是一门具有不确定性且不断动态发展的科学。医生既应

当遵守法律、法规和技术操作规范、常规，不断规范自己的执业行为，又应当努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平。

（3）亲自诊查患者，规范书写医学文书：医生实施医疗、预防、保健等措施，签署有关医学证明文件，必须亲自诊查、调查，并按照规定及时填写医学文书，不得隐匿、伪造或销毁医学文书及有关资料；医生不得出具与自己执业范围无关或者与执业类别不相符的医学证明文件。未经医生亲自诊查，医疗机构不得出具疾病诊断书、健康证明书或者死亡证明书等证明文件；未经医生、助产人员亲自接产，医疗机构不得出具出生证明书或者死产报告书。医疗机构及其医务人员应当按照规定填写并妥善保管住院志、医嘱单、检验报告、手术及麻醉记录、病理资料、护理记录等病历资料。

（4）应招义务：又称应诊义务、应需义务，即在特殊的情况下，医生必须进行诊治、采取措施或服从调遣的义务。对急危患者，医生应当采取紧急措施及时进行诊治，不得拒绝急救处置；遇有自然灾害、传染病流行、突发重大伤亡事故及其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时，医生应当服从县级以上人民政府卫生行政部门的调遣。

（5）履行知情同意：医生在诊疗活动中应当向患者说明病情、医疗措施和其他需要告知的事项。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医生应当及时向患者具体说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其明确同意；不能或者不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其明确同意。无法取得患者意见又无家属或者关系人在场，或者遇到其他特殊情况时，经治医生应当提出医疗处置方案，在取得医疗机构负责人或者被授权负责人的批准后实施。

（6）开展预防保健及健康教育：宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育是医生应当履行的义务之一。

（7）保护患者隐私：患者的隐私包括信息的隐私、身体的隐私和疾病的隐私。医务人员应当关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私。医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私和个人信息保密。泄露患者的隐私和个人信息，或者未经患者同意公开其病历资料，并造成患者损害的，应当承担侵权责任。

（8）合理检查、使用药品和医疗器械：医生应当使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械。除正当治疗外，不得使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品。医疗机构及其医务人员不得违反诊疗规范实施不必要的检查。

（9）不收受患者财物：医生不得利用职务之便，索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益。

（10）报告义务：医生发生医疗事故或者发现传染病疫情时，应当依照有关规定及时向所在机构或者卫生行政部门报告；医生发现患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡时，应当按照有关规定向有关部门报告。

（三）患者的权利与义务

1. 患者的权利

（1）生命权（right of life）：是指公民的生命安全不受侵犯，任何人均无权剥夺、危害他人生命。

（2）健康权（right of health）：是指自然人以其器官乃至整体功能利益为内容的人格权，其客体是人体器官及各系统乃至身心整体的安全运行，以及功能的正常发挥。

生命权和健康权是公民最基本人权。体现在医疗活动中，要求医务人员注意履行义务，谨慎地开展医疗活动，最大限度避免医疗缺陷、不良医疗事件或医疗事故的发生。

（3）身体权（bodily right）：是自然人所具有的依法维护其身体完整，对其身体组织和器官具有支配权的具体人格权。身体权是以身体为客体，强调的是保持身体的完整性、完全性。身体权禁止医生擅自摘取尸体组织、器官；禁止医生非法保留、占有患者身体组织；禁止医生过度实施外科手术，侵害患者的身体。

（4）知情同意权（the right of informed consent）：是在医生充分告知患者病情及诊疗方案的基础上，

NOTES

患者或其代理人所作出的同意或拒绝的选择。

（5）决定权（right to determination）：是指患者对自己的生命和健康相关利益具有自主决定的权利。在医疗活动中，患者享有充分了解自己所患疾病、治疗方案、存在风险等信息，以及按照自己意愿进行选择的权利。患者自主决定权主要包括：①有权自主选择医疗机构、医疗服务方式和医务人员；②有权自主决定接受或不接受任何一项医疗服务，特殊情况如患者生命垂危、神志不清不能自主表达意见时，可由患者的关系人决定；③有权拒绝非医疗性活动；④有权决定出院时间，但患者只能在医疗终结前行使此项权利，且必须签署书面声明，说明出院是自愿行为，医方已尽到了告知义务，对可能出现的危害已知情，发生任何问题与医疗机构无关；⑤有权决定转院治疗，但在病情极不稳定或随时有危及生命可能的情况下，应签署一份书面文书，说明是在医方的充分告知和沟通的基础上患方自行作出的决定；⑥有权根据自主原则自付费用与其指定的专家讨论病情；⑦有权拒绝或接受任何指定的药物、检查、处理或治疗，并有权知道相应的后果；⑧有权自主决定其遗体或器官如何处置；⑨有权享受来访及与外界联系，但应在遵守医院规章制度的基础之上；⑩其他依法应当由患者自主决定的事项。

（6）隐私权（right of privacy）：是指患者在诊疗过程中向医方公开的，不愿让他人知道的个人信息、空间和活动。一般来讲，患者的隐私包括：①基本信息，如姓名、身份证号、家庭住址、单位信息、经济状况等；②既往病史、家族史、婚姻史、生育史等；③隐私部位，如身体存在的生理缺陷、生殖系统信息等；④通过诊疗查明的精神和心理疾病；⑤乙型肝炎、丙型肝炎、血型、血液、精液等检查检验信息；⑥特殊经历或遭遇等其他信息。

（7）平等基本医疗权（right of the medical treatment）：患者不因男女、老幼、种族、贫富而有所差别，具有一律平等地享有基本医疗的权利。平等基本医疗权可以从实质上及形式上加以理解。实质上平等基本医疗权是指全体社会成员都具有平等享受基本医疗的权利，不因男女、党派、阶级、贫富等因素的不同而区别对待。形式上平等基本医疗权是指相同个案的医疗处理应该采用相同医疗方案和医疗准则，不同个案则采用不同方式。

（8）免责权（privilege of immunity）：是指患者因疾病处于身体、心理及精神方面的不适状态，不能像正常人一样完全履行职责和义务，可以凭医疗机构开具的证明，免除或部分免除一定的社会责任。同时，按照国家有关法律法规的规定，患者还具有得到休息和各种福利保障的权利。

2. 患者的义务

（1）积极配合诊疗：在诊疗过程中，患方应当充分尊重医务人员的劳动，信任并积极配合医生，按照选定的方案积极治疗，以达到早日康复的目的。

（2）如实提供信息：患者所提供的病史、症状、发病过程、诊疗经过等信息对医生的诊疗至关重要，所以患者应当全力配合医生，做到既不夸大其词，也不加以隐瞒。

（3）尊重医生：包括患方在内的全体社会成员应当尊重医生，医生享有在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯的权利。如果患者或家属对医务人员诊疗过程有异议，可以通过医疗机构、卫生行政部门或法院依法维护自身权益，不得“阻碍医师依法执业，侮辱、诽谤、威胁、殴打医师或者侵犯医师人身自由、干扰医师正常工作和生活”，否则将受到法律的制裁。

（4）遵守医院相关制度：医院的规章制度是医疗机构正常运行的基础，是切实保障患者权利、落实“以患者为本”理念的具体体现。患方应当自觉遵守医院的诊疗秩序和管理规定，以便更好地保障自身权利的实现和正常诊疗工作的顺利进行。

（5）支付诊疗费用：医生利用专业知识和技能为患者提供诊疗服务，付出了一定体力和脑力劳动，有获取正当劳动报酬的权利；而患者通过接受医疗服务而减轻痛苦、延长生命、恢复健康，有承担为此支付费用的义务。

（6）配合医学教学和研究：“没有全民健康，就没有全面小康。”卫生与健康事业与每一名社会成员都息息相关。因此，应该主动增强健康意识，自觉参加促进健康的事业，在不损害本人利益和健康的前提下，积极参与医学教学和研究工作，贡献自己的力量。

NOTES

（7）特殊情况下接受强制医疗：严重精神病或法定传染病患者可能会对他人和社会构成严重危害，因而我国法律法规规定这样的患者必须按相关规定接受强制检查、强制隔离或治疗。

二、全科医学中常见的法律问题

全科医学服务对象通常是固定区域的固定人群，工作内容涵盖疾病预防、诊断、治疗、控制、康复及健康教育等各个方面，医患之间沟通相对频繁，彼此了解相对深入，信任程度相对较高，所以医患关系总体上是和谐融洽的。但是，随着经济社会的发展，法治建设的不断完善，人们维权意识逐步增强，对医疗服务水平的要求也逐步提高，加上全科医生在医德修养、技术水平、沟通能力等方面的差异，如有不慎就可能引发医患纠纷，甚至医患双方对簿公堂。因此，一名合格全科医生不仅要追求医德修养、技术水平、沟通能力等各项素质的提升，还要把法治思维融入自己的价值观与思维模式之中，自觉地学法、知法、用法，尊重患者的权利，规范诊疗行为，用法律思维来看待医疗行为与医患关系。

（一）与诊断相关的法律问题

与诊断相关的法律问题主要包括误诊和出具诊断证明两个方面。

1. 误诊（misdiagnosis） 误诊是指当确诊的客观条件具备时，医者的诊断努力结束时，未能得出正确诊断。寻求全科医疗服务的患者，首次就诊时通常具有不典型症状和处于疾病未分化期，疾病的不确定性较大。澳大利亚一项针对全科医生的调查表明，97% 的全科医生认为自己会犯错误，诊断不清、误诊、漏诊在全科医疗中时有发生。误诊的影响因素是多方面的，包括患者对病情的表述、个体差异、病情复杂程度、症状是否典型、医疗机构诊疗设备、医务人员诊疗经验和技术水平以及责任心等。如果因为责任心欠缺而导致误诊，或者因为医务人员明知会发生诊断错误，却未采取措施，任由误诊发生，那么医务人员将承担误诊法律责任。但发生无过失误诊时，医疗机构及其医务人员是免责的。《中华人民共和国民法典》规定，有下列情形之一的，医疗机构不承担法律责任：①患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗；②医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务；③限于当时的医疗水平难以诊疗。

2. 诊断证明（diagnostic proof） 是医疗卫生机构出具给患者或其家属的具有法律效力的证明文件，包括出生证明、健康证明、疾病证明、伤残证明、功能鉴定书、医学死亡证明等证明文件。医学诊断证明可以作为司法鉴定、因病休假、办理病退、工伤认定、残疾鉴定、保险理赔、交通事故赔偿等的重要依据。医生在注册的执业范围内出具相应的诊断证明文件是其法定权利，也是其应履行的法定义务。被诊断为某种疾病有时意味着可以免除或部分免除一定的社会职责，如休学、休假等。因此，全科医生要意识到自己所出具的诊断证明的重要性。按照《中华人民共和国医师法》与《医疗机构管理条例》的规定，“医师出具证明文件，必须亲自诊查、调查，不得出具与自己执业范围无关或者与执业类别不相符的医学证明文件”。

针对以上问题，全科医生在出具诊断证明时须注意：①疾病诊断一定要根据患者的病情，本着实事求是的原则；②应优先排除急危重症疾病，如果不能排除，应建议患者及时转诊至上级医院进一步诊治；③出具诊断证明是医生应尽的义务，不得附加任何额外要求；④诊断证明仅记载疾病名称、住院时间、处置意见等内容，不得记录如诊疗费用等与诊断无关内容；⑤诊断书只能由经治医生出具，未经亲自诊查不得出具。

（二）与住院管理相关的法律问题

1. 患者民事行为能力的判断 住院管理是围绕患者住院过程中，为使患者尽早康复，避免不利因素影响，保证医疗质量而制定的一系列管理制度。全科医生要对住院患者的民事行为能力作出正确判断。《中华人民共和国民法典》规定根据自然人的不同情况，将自然人的民事行为能力分为三种：①十八周岁以上的公民，或以自己劳动收入为主要生活来源的十六周岁以上不满十八周岁的公民，是完全民事行为能力人；②八周岁以上的未成年人，或不能完全辨认自己行为的成年人是限制民事行为能力人；③不满八周岁的未成年人、八周岁以上的未成年人不能辨认自己行为的，以及不能辨认自己

行为的成年人是无民事行为能力人。限制民事行为能力人和无民事行为能力人的监护人是其法定代理人。因此，全科医生在进行病情告知，签署特殊治疗、特殊检查同意书，强调诊疗注意事项等医疗活动时，应对具有完全民事行为能力患者本人（或其代理人）、限制民事行为能力或无民事行为能力患者的代理人进行如实、客观、全面的告知，取得其明确同意，并签署医疗文书。

2. 患者外出发生意外伤害　住院患者外出发生意外伤害事件的法律问题取决于外出情况、受伤害情况及与医务人员的责任关系。全科医生要重视对住院患者外出情况的管理，原则上住院患者尽量不要外出或减少外出。但全科医生管理的住院患者往往为社区居民，离家较近，对周边环境较熟悉，常常会发生外出的情况。此时，全科医生应当告知患者或其代理人患者目前的病情是否适合外出，如外出须告知患者和其关系人注意事项。当患者外出发生意外伤害时，医务人员如果已尽到告知义务，则没有过失，不需要承担法律责任；反之，则要承担法律责任。

（三）与急救、转诊相关的法律问题

1. 急救与转诊相关的法律规定　社区医疗卫生服务机构与居民家庭距离近，全科医生与居民关系友好，所以居民在家中发生急症时，往往所在社区的社区医疗卫生服务机构就是首选的就医机构。《医疗机构管理条例》规定："医疗机构对危重病人应当立即抢救。对限于设备或者技术条件不能诊治的病人，应当及时转诊。"《中华人民共和国医师法》规定："对需要紧急救治的患者，医师应当采取紧急措施进行诊治，不得拒绝急救处置。因抢救生命垂危的患者等紧急情况，不能取得患者或者其近亲属意见的，经医疗机构负责人或者授权的负责人批准，可以立即实施相应的医疗措施。国家鼓励医师积极参与公共交通工具等公共场所急救服务；医师因自愿实施急救造成受助人损害的，不承担民事责任。"2006 年，国家卫生行政部门印发的《城市社区卫生服务机构管理办法（试行）》规定，"社区现场应急救护"是社区卫生服务机构应提供的基本医疗服务内容之一。全科医生在工作过程中，不得拒绝接诊急诊患者，尤其是生命垂危、需要立即给予抢救的患者，因故意拖延、推诿造成急诊患者损害的，将承担相应的法律责任。

2. 急救与转诊的注意事项　①在经治医生通过诊查、判断后，发现因本机构设备、技术条件限制不能诊治的患者，应当及时转诊。但全科医生如果根据现有条件能够判断出患者病情可能在转诊过程中加重或死亡时，应就地对患者进行紧急处置，待病情相对稳定或度过危险期后，再行转诊。急诊患者应当转诊而病情又允许的，全科医生应与拟转诊机构取得联系，通知有关人员做好相应准备。同时，协调患者关系人或 120 急救人员，对患者病情、途中注意事项、所需物品和药品、护理等做好交代和安排。如有病历，应将病历摘要、检查检验单据交给对方。②在决定患者是否需要转诊时，全科医生判断的原则主要基于"安全性"考虑，既要有利于患者的科学治疗，又要考虑拟转诊机构在距离、时间上的可及性。③在全科医生已经尽到告知义务，患者仍然拒绝转诊，或者患者病情不具备转诊条件（如病情危急，且路途遥远，转诊很容易发生危险），但患者或其关系人仍然坚持转诊而产生不良后果时，全科医生不承担相应法律责任。

（四）与健康档案相关的法律问题

健康档案（health record）是居民疾病防治、健康保护、健康促进等健康管理过程的规范、科学的记录，是以居民健康为核心，贯穿全生命过程，涵盖各种健康相关因素，实现多渠道信息动态收集，满足居民自我保健、健康管理和健康决策需要的信息资源。建立起覆盖城乡居民的、符合基层实际的统一、科学、规范的健康档案，已经被国家纳入 14 项国家基本公共卫生服务项目之一，所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。一方面，由于居民健康档案记录了大量公民基本信息和健康记录，涉及公民的隐私内容，需要全科医生妥善保管，避免档案损坏、丢失，防止信息泄露。《中华人民共和国民法典》规定"医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私和个人信息保密，泄露患者隐私和个人信息，或者未经患者同意公开其病历资料的，应当承担侵权责任"。另一方面，居民对个人健康信息具有知情权，当居民本人需要时，全科医生应当予以提供。所以，在全科医学实践中，全科医生应当注意对居民隐私权和知情权的维护，以避免侵权行为的发生。

（五）与家庭医疗服务相关的法律问题

家庭医疗服务（family medical service）是社区医疗卫生服务的特色，具有缓解医院床位紧张、减轻经济压力、方便患者家属陪护、保持患者心情舒畅、避免医院内感染等优势，经济和社会效益显著。2006 年，国家卫生行政部门印发的《城市社区卫生服务机构管理办法（试行）》规定“家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务”是社区卫生服务机构基本医疗服务内容。家庭医疗服务在为居民提供便利的同时，也不可避免地增加了医疗卫生机构的风险，需要引起全科医生的高度重视。一般情况，家庭医疗卫生服务存在的法律问题包括三个方面。

1. 疾病的医源性传播及医疗废物处理 《中华人民共和国传染病防治法》规定，医疗机构必须严格执行相关管理制度、操作规范，防止传染病的医源性感染；《消毒管理办法》规定，医务人员应当接受消毒技术培训、掌握消毒知识，并按规定严格执行消毒隔离制度；《医疗废物管理条例》规定，医疗机构应当及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。由于家庭诊疗环境特殊，空间和布局受限，所以全科医生在提供家庭医疗服务时，一定要严格执行消毒隔离制度，处理好废弃物，避免家庭成员、医务人员和社区人群受到服务对象的感染和交叉感染。

2. 家庭医疗服务的规范化管理 1984 年，国家卫生行政部门下发了《家庭病床暂行工作条例》，对任务和收治范围、制度和纪律、器械装备、组织领导等内容都作出了规定，但经过多年的发展，该制度对当前家庭医疗服务的约束已远远不足。所以，社区医疗卫生机构在提供家庭医疗服务之前，一定要细化相应的管理规定，包括家庭病床建立标准、医护准入资质要求、三级医生查房制度、值班交接班制度、病历书写制度及查房、转诊、会诊、抢救、护理、药品管理等有关规定，以保证管理科学化，工作制度化，操作规范化。

3. 医疗纠纷的防范 家庭病床条件相对简陋，不具备独立的治疗、护理单元，缺乏相应的抢救药品、医疗器械等，必然会存在着医疗安全隐患和风险。所以，社区医疗卫生服务机构要定期加强承担家庭医疗服务的人员的法律法规、医德医风、患者权利与义务、诊疗护理规范常规等方面的培训与教育，切实规范医务人员的行为，提高医务人员的法律意识。

（王永晨）

思考题

1. 全科医疗中的医患关系与其他专科医疗中的医患关系有何区别？建立并维护良好医患关系的途径有哪些？
2. 全科医学中的医患沟通有哪些语言性沟通技巧及非语言性沟通技巧？
3. 请概述医患权利与义务的主要内容。
4. 除了本章谈到的全科医学常见法律问题，还有哪些法律问题？你认为应该如何应对？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图